A PÁCIENS IGENT MOND™ · FŐ ANYAG

Betegtájékoztató szövegek 40 esettípushoz

Kész beszélgetési szövegek 40 esettípushoz, hogy a vizsgálat után egyszerűen, őszintén és nyomás nélkül mutasd be a tervet a páciensnek vagy a szülőnek.

Tartalom

1 · Használati útmutató és az etikus tájékoztatás elvei

2 · I. osztály és helyproblémák (01–08. eset)

3 · II. osztályú esetek (09–16. eset)

4 · III. osztályú esetek (17–21. eset)

5 · Vertikális és Transzverzális Problémák (22–28. eset)

6 · Fogszám és fogpozíció (29–34. eset)

7 · Felnőttek és különleges helyzetek (35–40. eset)

8 · Ellenőrzőlista a tájékoztatás után

1. FEJEZET

Használati útmutató

Minden eset egy oldal: először nézd meg a keretet, aztán mondd el a szöveget a saját szavaiddal.

> *Ezek a szövegek nem bemagolandó forgatókönyvek. Váz, amelyet a páciens dokumentációjának megtekintése után a hozzád illő szavakkal tölthetsz meg.*

1. **Keresd meg az esettípust.** A tartalomjegyzékből vagy a fejezet eleji táblázatból válaszd ki a legközelebbi esettípust. Ha több probléma is van, először azt használd, amely a páciens panaszához a legközelebb áll.
2. **Olvasd el a klinikai keretet.** A dobozban lévő információ neked szól, a páciensnek nem olvasod fel. Húzd ki a szövegből azt a mondatot, amely nem egyezik a saját leleteiddel.
3. **Mondd el a szöveget egyszerű nyelven.** Ha szakkifejezést kell használnod, rögtön utána mondd el hétköznapi szavakkal is.
4. **A készüléket vagy az extrakciót külön magyarázd el.** Ez az információ a fő szöveg után következzen, és csak azután, hogy hagytál időt a páciens kérdéseinek.
5. **Figyelj a kerülendő kifejezésekre.** A jobb oldali oszlop mondatai ugyanazt az információt adják át nyomás és ígéret nélkül.
6. **Ellenőrizd, hogy érthető volt-e.** Kérdezd meg: «Össze tudná foglalni a saját szavaival, amit elmondtam?» Ne várj döntést ugyanazon a napon.

AZ ETIKUS TÁJÉKOZTATÁS 6 ELVE	A GYAKORLATBAN
1 · Először hallgasd meg	Rögzítsd a páciens vagy a szülő panaszát és elvárását az ő szavaival; onnan indulj a tervvel.
2 · Írd le, amit látsz, ne ítélkezz	«Ferde», «elrontott», «rossz» helyett leíró szavak: «előrébb áll», «zsúfolt», «fordítva záródik».
3 · Mutasd be a lehetőségeket	Minden megfelelő lehetőséget, a kezelés elhagyását és a megfigyelést is beleértve. A javaslatodat és annak okát külön mondd el.
4 · Ne ígérj	Az időtartamra hozzávetőleges sáv, az eredményre cél. Nincs «biztosan», «garantáltan», «tökéletes».

AZ ETIKUS TÁJÉKOZTATÁS 6 ELVE	A GYAKORLATBAN
5 · Mondd ki egyértelműen a páciens feladatát	Szájhigiénia, elasztikus vagy készülék viselése, a kontrollvizitek betartása és a retenció.
6 · Adj időt a döntésre	Ne várj döntést ugyanazon a napon. Engedd, hogy hazavigye az írásos tervet és a rendelőd által használt beleegyező nyilatkozatot.

Minden tájékoztatás 5 részes váza

RÉSZ	KÉRDÉS	PÉLDA NYITÓMONDAT
1 · Amit látok	Mit találtam?	«A vizsgálaton és a felvételeken ezt látjuk…»
2 · Miért fontos	Mi történhet kezelés nélkül?	«Ez idővel a következőkhöz vezethet…»
3 · Mit javaslok	Cél és módszer	«A célunk… Ehhez az általam javasolt út…»
4 · Lehetőségek	Más utak és korlátaik	«Vannak más lehetőségek is; ezek előnyei és korlátai…»
5 · Az Ön szerepe és a következő lépés	Mit tesz a páciens?	«Öntől azt kérjük… A következő lépésünk…»

Minden esetben érvényes: ne mondd

Az olyan kifejezések, mint «garantálom», «egyáltalán nem fáj», «ha ma dönt», «a másik orvos rosszul mondta», «nagyon könnyű eset», «biztosan ennyi hónap alatt kész», «nem lesz szükség műtétre», elvárásokat keltenek és rombolják a bizalmat.

2. FEJEZET

I. osztály és helyproblémák

Az állcsontok viszonya kiegyensúlyozott; a probléma a fogsorrendben, a helyben és a résekben van.

> *Ebben a fejezetben a 01–08. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.*

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
01	I. osztály, enyhe torlódás	Páciens (felnőtt)	Az okklúzió kiegyensúlyozott, a gond a fogsorrend
02	I. osztály, közepes torlódás	Serdülő és szülő	Helyet kell nyitni, a módszert közösen választjuk
03	I. osztály, súlyos torlódás	Páciens vagy szülő	Jelentős helyhiány; az extrakciós lehetőség indoklással
04	Bimaxilláris protrúzió	Páciens (serdülő vagy felnőtt)	A fogak és az ajkak előrébb állnak; a cél az egyensúly megbeszélése
05	Középvonali diasztéma (felnőtt)	Páciens (felnőtt)	Az ok feltárása nélkül nincs résbezárás
06	Általános hézagos fogazat	Páciens	A rések oka és a teendő közösen
07	Középvonal-eltolódás	Páciens	Az eltolódás forrása a fog vagy az állcsont?
08	Torlódás vegyes fogazatban (gyermek)	Szülő	Most megfigyelés vagy most beavatkozás?

I. osztály, enyhe torlódás

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Az okklúzió kiegyensúlyozott, a gond a fogsorrend**

Klinikai keret (az orvosnak): Moláris és szemfogi viszony I. osztály, a csontos alap harmonikus. A frontrégióban enyhe torlódás; IPR-rel vagy korlátozott ívtágítással várhatóan megoldható.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A vizsgálat alapján az állcsontjai egymáshoz való viszonya és a harapása összességében kiegyensúlyozott. A gond inkább a fogak elrendeződésében van: főleg az elülső fogaknál látok enyhe zsúfoltságot. Ez megnehezítheti a fogközök tisztítását, és az évek során kissé fokozódhat. A kezelés célja, hogy a fogakat a csontban szabályos sorba rendezzük, és megőrizzük a mostani jó harapását. Az ilyen esetekben legtöbbször nincs szükség foghúzásra. Az időtartamra ma nem lenne helyes pontos számot mondanom; hozzávetőleges sávot tudok adni, és az első kontrollok után pontosabban beszélünk róla. A kezelés végén a rögzítő viselése az eredmény megőrzésének része. Mielőtt döntene, bármit megkérdezhet, ami eszébe jut.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

Ha IPR szükséges: «A fogak oldalfelszínéről nagyon vékony, kimért zománcréteget távolítunk el. Így foghúzás nélkül nyerünk egy kis helyet. Általában nem igényel érzéstelenítést; előre megtervezzük, mennyit veszünk el.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ez nagyon egyszerű, gyorsan kész lesz.	✓ A terv egyértelmű; az időtartamot az első kontrollok után pontosítjuk.
✗ Lereszeljük a fogait.	✓ Az oldalfelszíneken kimért, nagyon vékony korrekciót végzünk.
✗ A retenció nem kötelező.	✓ A retenció a kezelés utolsó, tartós szakasza.

I. osztály, közepes torlódás

Kinek: Serdülő és szülő **Fő üzenet: Helyet kell nyitni, a módszert közösen választjuk**

Klinikai keret (az orvosnak): I. osztályú viszony, közepes mértékű torlódás. A helyanalízis alapján tágítás, IPR vagy extrakció is szóba jöhet; a profil és az ínyállapot a döntő.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az állcsontok egymáshoz viszonyított helyzete kiegyensúlyozott, de a fogak számára rendelkezésre álló hely valamivel kevesebb, mint a fogak összes szélessége. Ezért egyes fogak előrébb, hátrébb vagy elfordulva nőttek ki. Ahhoz, hogy szabályosan sorba rendezzük őket, először helyet kell nyitnunk. Ennek több módja van: a fogív kontrollált tágítása, a fogak oldalfelszínéről minimális zománc eltávolítása, vagy egyes esetekben foghúzás. Hogy melyik a megfelelő, azt az arcprofil, az ajkak alátámasztása és az íny állapota együttes vizsgálatával döntjük el. Ma elmondom a lehetőségeket és mindegyik előnyét, hátrányát. Bármelyik utat választjuk, a rendszeres kontroll, a jó szájhigiénia és a kezelés utáni retenció a siker alapja.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

Ha felmerül az extrakció: «A foghúzás csak egyike a helynyerés módjainak. Ha javaslom, a felvételeken megmutatom az okát: a helyigényt és az Ön profilját. A döntést közösen hozzuk meg.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Foghúzás nélkül nem megy.	✓ Értékeljük együtt a lehetőségeket és mindegyik következményét.
✗ Olyan lesz, mint a barátjáé.	✓ Minden eset terve a saját dokumentációja alapján készül.
✗ Nyitunk egy kis helyet, és kész.	✓ A helynyerésnek három útja van; közösen választjuk ki az Önnek megfelelőt.

I. osztály, súlyos torlódás

Kinek: Páciens vagy szülő **Fő üzenet: Jelentős helyhiány; az extrakciós lehetőség indoklással**

Klinikai keret (az orvosnak): Jelentős helyhiány; a szemfog az ívből kiszorult, vagy a fogak egymásra torlódnak. A helyanalízis és a profilértékelés alapján az extrakciós terv erős lehetőség.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A fogak összes szélessége jelentősen nagyobb annál, amennyi hely az állcsontban rendelkezésre áll. Ezért egyes fogak kiszorultak a sorból. Ekkora helyigény esetén ha a fogakat csak tágítással rendezzük sorba, azok kitolódhatnak a csontból, vagy előretolhatják az ajkakat. Ez az íny egészsége és az eredmény tartóssága szempontjából is kockázatos. Ezért az Ön esetében egyes fogak eltávolítását lehetőségként javaslom. Ezt a döntést nem könnyen hozzuk meg; a felvételeket, az arcprofilját és az íny állapotát együtt értékeltük. A foghúzás nélküli út előnyeit és korlátait is őszintén elmondom. A végső döntést Önnel közösen hozzuk meg.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A foghúzás általában a kisőrlőfogakat érinti; a keletkező rést a kezelés során a fogak elmozdításával bezárjuk. A kezelés végére nem célunk, hogy rés maradjon a szájban. Hogy melyik orvos és mikor végzi a foghúzást, azt megtervezzük, és írásban átadjuk Önnek.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Négy fogat kihúzunk, nincs más út.	✓ A felvételei alapján az extrakciós terv erős lehetőség; a többi utat is elmondom.
✗ A foghúzás biztosan nem rontja el az arcát.	✓ A tervet a profilja figyelembevételével készítjük; ezt beszéljük meg a felvételek alapján.
✗ Utána maradhat rés, de nem számít.	✓ A rések bezárását a kezelés részeként tervezzük.

Bimaxilláris protrúzió

Kinek: Páciens (serdülő vagy felnőtt)

Fő üzenet: A fogak és az ajkak előrébb állnak; a cél az egyensúly megbeszélése

Klinikai keret (az orvosnak): A felső és alsó metszők előrébb állnak, az ajkak teltek, és lehet, hogy nehezen záródnak. Az extrakciós döntésben a profil és a páciens elvárása a meghatározó.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső és alsó elülső fogai az állcsonthoz képest kissé előre dőlnek. Emiatt az ajkai is előrébb látszanak, és előfordulhat, hogy erőlködnie kell az ajakzáráshoz. Először azt szeretném megkérdezni: zavarja valami a profiljában? Erre a válaszra a terv is változik. Ha a cél az elülső fogak hátrahúzása, ahhoz hely kell, és ezt a helyet legtöbbször foghúzással nyerjük. Ha elégedett a profiljával, egy korlátozottabb tervet is megbeszélhetünk, amely a fogakat a jelenlegi dőlésükben rendezi sorba. Mindkét út előnyeit és korlátait megmutatom a felvételeken. Az ajkak és az arc megjelenésének változása egyénenként eltérő; ezt előre biztosan megmondani nem lehet.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ahhoz, hogy az elülső fogakat hátra tudjuk húzni, hátul helyet kell nyitnunk. Ezt a helyet többnyire a kisőrlőfogak eltávolításával nyerjük. Szükség esetén kiegészítő lehorgonyzást, például minicsavart használhatunk, hogy a hátsó fogak ne vándoroljanak előre; ezt külön elmagyarázom.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Nagyon kiállnak az ajkai.	✓ Az ajkak a fogak dőlése miatt kissé előrébb állnak; zavarja ez Önt?
✗ Teljesen meg fog változni az arca.	✓ Az arc változása egyénenként eltérő; tisztázzuk együtt az elvárásainkat.
✗ Foghúzás nélkül értelmetlen a kezelés.	✓ Beszéljük meg egymás mellett, mit nyújt az extrakciós és a nem extrakciós terv.

Középvonali diasztéma (felnőtt)

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Az ok feltárása nélkül nincs résbezárás**

Klinikai keret (az orvosnak): Rés a felső középső metszők között. Értékelendő: frenulum, fogméret-eltérés, metszőfog-dőlés, hiányzó fog vagy parodontális ok.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A két elülső foga közötti rés bezárható, de előbb meg kell értenünk, miért alakult ki. Néha az ajak belső oldalán lévő szalag nyúlik be a fogak közé, néha a fogak kisebbek a szomszédos fogakhoz képest, máskor pedig a fogak előre dőlnek. Az íny és a csont állapota is része ennek a vizsgálatnak. Az ok tisztázása után a rést fogszabályozással bezárhatjuk, és szükség esetén a fogorvosával együtt a fogak formáját is korrigálhatjuk. Az ilyen rések bezárás után hajlamosak újra kinyílni. Ezért azt javaslom, hogy az elülső fogak belső felszínére vékony, rögzített retenciós drótot ragasszunk, és ezt hosszú ideig tartsuk meg.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

Ha frenectomia vagy konzerváló kiegészítés szükséges: «Lehet, hogy a szalagot egy kis beavatkozással korrigálni kell, vagy a fogak formáját tömőanyaggal kell szélesíteni. Ennek sorrendjét és azt, hogy ki végzi, külön elmagyarázom.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Két hónap alatt bezárjuk, és kész.	✓ Előbb keressük meg az okot; utána beszéljünk az időtartamról és a módszerről.
✗ Ha bezárul, többé nem nyílik ki.	✓ Ezek a rések hajlamosak újra kinyílni; ezért fontos a retenció.
✗ Az ínyprobléma az Ön hibája.	✓ Az íny egészségét együtt értékeljük és óvjuk.

Általános hézagos fogazat

Kinek: Páciens | Fő üzenet: A rések oka és a teendő közösen

Klinikai keret (az orvosnak): Több fogközi rés; lehetséges okok: fogméret-eltérés, nyelvhelyzet, metszőfog-protrúzió vagy parodontális vándorlás.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A fogai közül sok között rés van. Ez általában akkor fordul elő, ha a fogak az állcsonthoz képest kicsik, ha a nyelv nyomja a fogakat, vagy ha a fogak legyezőszerűen előre dőlnek. Az íny és a csont állapotát is ellenőriztük, mert a rések néha ínybetegség következtében alakulnak ki később. A kezelés során a rések bezárásával együtt az elülső fogak dőlését is korrigálhatjuk. Egyes esetekben esztétikusabb eredményt ad, ha nem zárunk be minden rést, hanem helyet hagyunk a fogak formájának tömőanyaggal történő korrekciójához; ezt a fogorvosával közösen tervezzük meg. Hézagos fogazatnál a retenció különösen fontos. Ha van nyelvszokása, az is segít az eredmény megőrzésében, ha tudatában van ennek.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Egyes réseket ahelyett, hogy teljesen bezárnánk, kimért helyet hagyhatunk a fogak formájának korrekciójához. Ezt a döntést a mosolyában látható fogarányok alapján közösen hozzuk meg.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A nyelve miatt romlott el.	✓ A nyelv helyzete befolyásolhatja a réseket; ezt közösen követjük.
✗ Mindet bezárjuk, semmi gond.	✓ Tervezzük meg a fogarányai alapján, mely réseket zárjuk be.
✗ Nem lesz szükség retencióra.	✓ Hézagos fogazatnál a retenció szükséges az eredmény megőrzéséhez.

Középvonal-eltolódás

Kinek: Páciens **Fő üzenet: Az eltolódás forrása a fog vagy az állcsont?**

Klinikai keret (az orvosnak): A felső és/vagy alsó középvonal az arc középvonalához képest eltolódott. El kell különíteni: dentális eltolódás, funkcionális eltolódás vagy csontos aszimmetria.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső és alsó elülső fogai közepe nincs pontosan egy vonalban az arca közepével. Ennek több lehetséges oka van: maguk a fogak tolódtak el, az állkapocs záráskor egyik oldalra csúszik, vagy ritkábban magának az állcsontnak van aszimmetriája. A vizsgálaton és a felvételeken igyekeztünk elkülöníteni, melyikről van szó. A fogakból eredő eltolódások legtöbbször fogszabályozással javíthatók. Ha az állcsontból eredő eltérés van, őszintén meg kell mondanom, mennyit tudunk belőle korrigálni. Néha a középvonal tökéletes középre hozása a harapás rovására menne; ilyenkor az egészséges és kiegyensúlyozott harapás az elsődleges. Határozzuk meg együtt, reálisan a kezelési célt.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

Ha aszimmetrikus mechanika vagy kiegészítő lehorgonyzás szükséges: «Hogy az egyik oldalon a fogakat másként mozgassuk, mint a másikon, elasztikust vagy minicsavart használhatunk. Lépésről lépésre megmutatom, hogyan kell ezeket használni.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A középvonalat milliméterre középre hozzuk.	✓ A célunk a kiegyensúlyozott harapás; beszéljük meg, meddig jutunk a középvonallal.
✗ Ferde az állkapcsa.	✓ A felvételeken kis különbséget látunk a két oldal között; elmondom, mit jelent.
✗ Úgysem veszi észre senki.	✓ Ha ez Önnek fontos, vegyük fel a célok közé.

Torlódás vegyes fogazatban (gyermek)

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Most megfigyelés vagy most beavatkozás?**

Klinikai keret (az orvosnak): Vegyes fogazati időszak, torlódás a frontrégióban. A helyanalízis, a tejfogak állapota és az áttörési sorrend határozza meg, hogy megfigyelés vagy korlátozott beavatkozás legyen.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke szájában jelenleg tejfogak és maradó fogak is vannak. Az elülső fogaknál látható zsúfoltság ebben az időszakban gyakori, és egy része csökkenhet, ahogy az állcsont nő és a tejfogak kicserélődnek. Ha azonban a helyhiány jelentős, néhány egyszerű intézkedéssel meg lehet könnyíteni a későbbi kezelést. A mai felvételek alapján vagy rendszeres megfigyelést, vagy korlátozott beavatkozást fogok javasolni, és elmagyarázom az okát. Ha a megfigyelés mellett döntünk, szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy «nem csinálunk semmit»: meghatározott időközönként ellenőrizzük és követjük a fogak áttörését. A tejfogak fogszuvasodás elleni védelme is fontos, mert a korán elvesztett tejfog szűkítheti a maradó fog helyét. Szívesen meghallgatom a kérdéseit és gyermeke véleményét is.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

Ha helytartó vagy korlátozott készülék szükséges: «Ezt a készüléket arra használjuk, hogy megőrizzük vagy kissé tágítsuk a helyet, ahol a maradó fogak előbújnak. Ez nem végleges kezelés; a célja a későbbi kezelés megkönnyítése.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha várunk, a fogai biztosan elromlanak.	✓ Egyes torlódások maguktól is csökkenhetnek; rendszeres kontrollal követjük.
✗ Ha most kezdjük, később nem kell fogszabályozó.	✓ A korai beavatkozás megkönnyítheti a későbbi kezelést; tudnia kell, hogy később is szükség lehet kezelésre.
✗ Még túl korai, nem lehet mit tenni.	✓ Ennek az időszaknak a kontrollvizitekkel való követése is kezelési terv.

3. FEJEZET

II. osztályú esetek

II. osztály gyermeknél, serdülőnél és felnőttnél; a növekedés lehetősége és a kompenzáció határai.

Ebben a fejezetben a 09–16. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
09	II. osztály 1. alosztály, gyermek	Szülő	A növekedés lehetőség; az együttműködés a döntő
10	II. osztály 1. alosztály, serdülő	Serdülő és szülő	A növekedési csúcs jó kihasználása
11	II. osztály 1. alosztály, felnőtt	Páciens (felnőtt)	Nincs növekedés; kompenzáció a határaival
12	II. osztály, felnőtt, sebészi határeset	Páciens (felnőtt)	Őszinte összevetés a kompenzáció és a műtét között
13	II. osztály 2. alosztály, gyermek	Szülő	Meredek metszők és mélyharapás; megfigyelés vagy korai korrekció
14	II. osztály 2. alosztály, felnőtt	Páciens (felnőtt)	A mélyharapás hatása a fogakra és az ínyre
15	Dentális II. osztály, harmonikus csontos alap	Páciens	A gond nem az állcsont, hanem a fogpozíció; disztalizációs lehetőség
16	Megnövekedett overjet, traumakockázat (gyermek)	Szülő	Az előreálló fogak ki vannak téve az ütéseknek

II. osztály 1. alosztály, gyermek

Kinek: Szülő **Fő üzenet: A növekedés lehetőség; az együttműködés a döntő**

Klinikai keret (az orvosnak): Növekedésben lévő gyermek; megnövekedett overjet, hátrahelyezett mandibula benyomása. Funkciós készülék vagy megfigyelés; az együttműködés és a növekedési szakasz a döntő.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke felső elülső fogai jóval az alsó fogak előtt állnak. A felvételeken látjuk, hogy ennek jelentős része azzal függ össze, hogy az alsó állcsont a felsőhöz képest hátrébb van. Gyermeke még növekedésben van, és ez lehetőséget ad nekünk: bizonyos készülékekkel megpróbálhatjuk támogatni a növekedés irányát. Ezeknek a készülékeknek a hatása nagyrészt a rendszeres viseléstől függ, vagyis gyermeke és az Ön hozzájárulása is az eredmény része. Előre nem tudhatjuk biztosan, mennyit tesz hozzá a növekedés, ezért a haladást a kontrollokon méréssel követjük. Ezt a szakaszt követően a fogak rendezéséhez rögzített kezelésre lehet szükség. Beszéljük meg együtt, milyen időzítés a megfelelő.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A funkciós készülék úgy működik, hogy az alsó állcsontot kissé előrébb tartja. Az első napokban a beszéd és az evés kissé szokatlan lehet; a legtöbb gyermek néhány hét alatt megszokja. Hogy mennyi ideig kell viselni, azt írásban átadom Önnek.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ezzel a készülékkel az állkapocs biztosan előrejön.	✓ A növekedés támogatására törekszünk; a hatását a kontrollokon mérjük.
✗ Ha nem hordja, az az Ön hibája.	✓ Alakítsunk ki együtt egy rutint a rendszeres viseléshez.
✗ Utána nem kell fogszabályozó.	✓ Ezt a szakaszt követően rögzített kezelés is kellhet; szeretném, ha ezt már az elején tudná.

II. osztály 1. alosztály, serdülő

Kinek: Serdülő és szülő **Fő üzenet: A növekedési csúcs jó kihasználása**

Klinikai keret (az orvosnak): Serdülő a növekedési csúcsban vagy annak közelében; megnövekedett overjet. Rögzített kezelés mellett funkciós támogatás, II. osztályú elasztikusok vagy extrakciós terv lehetősége.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az, hogy a felső elülső fogak az alsók előtt állnak, a megjelenést is befolyásolja, és azt is, hogy az elülső fogak védtelenebbek az ütésekkel szemben. Gyermeke most a gyors növekedés időszakában van; ez fontos lehetőség lehet arra, hogy a kezeléssel együtt az alsó és felső állcsont közötti különbséget is kezeljük. A tervünkben a fogakat rendező rögzített kezelés mellett olyan elasztikusok vagy készülékek is lehetnek, amelyek segítenek az állcsontok közötti viszony korrigálásában. Ezek hatása nagyrészt a rendszeres viseléstől függ, ezért a páciens és az otthoni támogatás szerepe is nagy. Előfordul, hogy ez az út nem elég, és felmerülhet egy foghúzásos kompenzációs terv; ezt a lehetőséget is már az elején nyíltan meg szeretném beszélni. Kérdéseiket – a páciens és a család is – nyugodtan feltehetik.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A II. osztályú elasztikusok kis gumik, amelyeket a felső és alsó ív közé akasztunk. Ezeket minden nap a páciens maga cseréli. Az első napokban nyomásérzés lehet a fogakban; ez általában néhány napon belül enyhül.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha nem hordja az elasztikusokat, elhúzódik a kezelés, utána ne nálam panaszkodjon.	✓ Az elasztikusok rendszeres viselése lerövidíti az utat a befejezésig; szóljon, ha valamelyik nap nem sikerült, és közösen megoldjuk.
✗ Teljesen helyrehozzuk az állkapcsot.	✓ Az állcsontok közötti különbség csökkentése a célunk; mérni fogjuk, mennyit haladunk.
✗ A növekedés véget ért, már késő.	✓ A növekedési állapotot a felvételek alapján értékeljük, és megbeszéljük a lehetőségeket.

II. osztály 1. alosztály, felnőtt

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Nincs növekedés; kompenzáció a határaival**

Klinikai keret (az orvosnak): Befejezett növekedésű felnőtt; II. osztályú viszony, megnövekedett overjet. Lehetőségek: dentális kompenzáció (extrakcióval vagy disztalizációval), sebészettel kombinált kezelés vagy korlátozott kezelés.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső elülső fogai jól láthatóan az alsók előtt állnak; a felvételeken látjuk, hogy ennek egy része az állcsontok helyzetével függ össze. Mivel a növekedése befejeződött, az állcsontok helyzetét készülékekkel már nem tudjuk megváltoztatni. Ehelyett két fő út van. Az első: a fogak helyzetét az állcsontokhoz igazítjuk; ehhez legtöbbször egyes fogak eltávolítására vagy a hátsó fogak hátrébb mozgatására van szükség. A második: ha nagy a különbség, a fogszabályozást állcsontsebészettel kombináljuk. Ma szeretném nyíltan elmondani, melyik út reális az Ön számára, mit korrigál és mit nem. Az arc megjelenésével kapcsolatos elvárásait is ismernem kell.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Az extrakciós tervben felül általában a kisőrlőfogakat távolítjuk el, és az elülső fogakat hátrahúzzuk. Hogy a hátsó fogak ne vándoroljanak nem kívánt módon előre, kiegészítő lehorgonyzásra, például minicsavarra lehet szükség; ez kis beavatkozás, és a kezelés végén eltávolítjuk.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Hátrébb van az állkapcsa, de a fogszabályozóval megoldjuk.	✓ A készülék a fogak helyzetét változtatja meg; az állcsont helyzetére vonatkozó lehetőségeket külön beszéljük meg.
✗ Ha nem akar műtétet, semmi gond, ugyanaz lesz.	✓ Megmutatom nyíltan, mit korrigál és mit nem a műtét nélküli terv.
✗ Már túl van a korhatáron.	✓ Felnőttkorban is lehetséges a kezelés; csak a lehetőségek mások.

II. osztály, felnőtt, sebészi határeset

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Őszinte összevetés a kompenzáció és a műtét között**

Klinikai keret (az orvosnak): Kifejezett csontos eltérés; határeset a kompenzáció és az ortognát sebészet között. Meg kell beszélni a profilt, a légúti panaszokat, a páciens elvárását és kockázatérzékelését.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az Ön esetében az állcsontok közötti különbség közel van ahhoz a határhoz, ameddig csupán a fogak mozgatásával teljesen kiegyenlíthető. Ezért két utat szeretnék egymás mellé tenni. Az első út: csak fogszabályozással igazítjuk a fogakat az állcsontokhoz. Ez javíthatja a harapást, de az arcprofil eltérését nagyrészt nem változtatja meg, és a fogak mozgatását a határaik közelébe vihetjük. A második út: a fogszabályozást állcsontsebészettel kombináljuk. Ez az állcsontok helyzetével is foglalkozik, de a műtétnek megvan a maga folyamata, gyógyulási ideje és kockázata. Hogy melyik út illik Önhöz, azt az Ön prioritásai alapján kell eldöntenünk. Ha szeretné, a sebészi lehetőséghez szájsebész szakorvos véleményét is kikérjük.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A sebészettel kombinált tervben először a fogakat készítjük elő a műtétre, ezután következik a műtét, majd a fogszabályozó befejezés. A műtét előtti szakaszban a megjelenés átmenetileg hangsúlyosabbá válhat; ez a terv része.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha nem vállalja a műtétet, nem tudok mit tenni.	✓ Beszéljük meg egymás mellett, mit nyújt a két lehetőség; a döntés az Öné.
✗ A műtét nagyon egyszerű.	✓ A műtétnek megvan a folyamata és a kockázata; értékeljük szakorvosi véleménnyel együtt.
✗ Fogszabályozóval is ugyanazt az eredményt érjük el.	✓ A fogszabályozás javítja a harapást; a profil változása korlátozott lehet.

II. osztály 2. alosztály, gyermek

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Meredek metszők és mélyharapás; megfigyelés vagy korai korrekció**

Klinikai keret (az orvosnak): A felső középső metszők befelé, az oldalsó metszők kifelé dőlnek; mélyharapás. Vegyes vagy korai maradó fogazat. A metszőfog-dőlés korrekciója és a harapásmélység követése.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke két felső elülső foga befelé dől, a mellettük lévő fogak pedig kifelé állnak. Ez olyan állapot, amely azzal jár együtt, hogy a fogak túlságosan fedik egymást. Az alsó fogak néha a felső fogak belső felszínéhez vagy a szájpadhoz közel záródnak. Ez a kép nemigen hajlamos magától rendeződni. Egyes gyermekeknél egy egyszerű készülék, amely korrigálja az elülső fogak dőlését, segíthet abban, hogy az alsó állcsont szabadabban mozogjon, és könnyebb legyen a későbbi kezelés. Másoknál a maradó fogak teljes áttöréséig a kontrollált megfigyelés a megfelelőbb. Ma elmondom, melyik utat javaslom gyermekének, és miért. Az íny és a szájpad esetleges irritációját minden kontrollon követni fogjuk.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Az általunk használt készüléket arra tervezték, hogy az elülső fogak dőlését kifelé korrigálja. Gyermeke az első napokban kissé nehezebben beszélhet. A készülék tisztításáról és a viselési időről írásos útmutatót adok Önnek.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ezek a fogak nagyon ferdék.	✓ Az elülső fogak befelé dőlnek; elmondom, hogyan korrigálható ez.
✗ Ha nem teszünk semmit, elromlik az állkapcsa.	✓ Ez az állapot nem hajlamos magától rendeződni; válasszuk ki együtt, mikor avatkozzunk be.
✗ Egy készülékkel minden megoldódik.	✓ Szeretném, ha már az elején tudná, hogy később rögzített kezelésre is szükség lehet.

II. osztály 2. alosztály, felnőtt

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: A mélyharapás hatása a fogakra és az ínyre**

Klinikai keret (az orvosnak): Felnőtt; meredek felső metszők, mélyharapás, esetleges alsó metszőkopás vagy szájpadirritáció. Terv a metszőfog-dőlés korrekciójára és a harapás nyitására.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső elülső fogai befelé dőlnek, és záráskor a felső fogak a szükségesnél jobban fedik az alsókat. Ennek néhány következményét a vizsgálaton is látjuk, például az alsó elülső fogak kopását vagy a szájpad érzékenységét. A kezelés célja, hogy korrigáljuk az elülső fogak dőlését, és csökkentsük a harapás mélységét. Így a fogak közötti érintkezést kiegyensúlyozottabbá szeretnénk tenni. Felnőttkorban az ilyen harapás nyitása időt vehet igénybe, és az eredmény megőrzéséhez különösen figyelnünk kell a kezelés utáni retencióra. Az íny állapota is része a tervnek. Nem tudom előre megmondani, hogy a kezelés megszünteti-e az állkapocsízületi panaszokat; ezt szeretném nyíltan jelezni.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A harapás nyitásához az elülső fogakat kissé befelé és felfelé kell irányítanunk. Egyes esetekben a hátsó fogakon kis harapásemelőket vagy kiegészítő lehorgonyzást, például minicsavart használunk. Ezek ideiglenesek, és külön elmagyarázzuk őket.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ezzel a kezeléssel elmúlik az állkapocsfájdalma.	✓ Nem tudom előre megmondani, hogyan hat a fogszabályozás az ízületi panaszokra; értékeljük külön.
✗ Elolvadnak a fogai.	✓ Az alsó elülső fogakon kopásnyomok vannak; beszéljünk egy tervről, amely ezt megállítja.
✗ Ez a harapás utána magától megmarad.	✓ A mélyharapás hajlamos visszatérni; ezért fontos a retenció.

Dentális II. osztály, harmonikus csontos alap

Kinek: Páciens **Fő üzenet: A gond nem az állcsont, hanem a fogpozíció; disztalizációs lehetőség**

Klinikai keret (az orvosnak): A csontos viszony elfogadható; a felső őrlőfogak előre vándoroltak (pl. korai tejfogvesztés után). Disztalizáció, minicsavarral támogatott mechanika vagy extrakció lehetősége.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az állcsontjai egymáshoz viszonyított helyzete elfogadható határokon belül van. A gond inkább abból adódik, hogy a felső hátsó fogak idővel előre vándoroltak; ez szűkíti az elülső fogak helyét, és megváltoztatja a harapást. Ilyenkor a kezelés során megfontolhatjuk a felső hátsó fogak kontrollált hátrébb mozgatását. Ehhez egyes esetekben a fogak mellett kis kiegészítő eszközöket, például minicsavart használunk; ezek megakadályozzák, hogy a fogak nem kívánt irányba mozduljanak. A másik lehetőség, hogy egyes fogak eltávolításával nyerünk helyet. Beszéljük meg mindkét út előnyeit és hátrányait az időtartam, a kényelem és az eredmény szempontjából. A választott terv sikere attól is függ, hogy rendszeresen eljön-e a kontrollokra.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A minicsavar egy nagyon kicsi, ideiglenes csavar, amelyet a fogak közötti csontba helyezünk. Érzéstelenítésben, rövid idő alatt behelyezhető, és a kezelés végén eltávolítjuk. Az első napokban enyhe érzékenység lehet a területen.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Csavart teszünk be, nincs mitől félni.	✓ Elmondom, mi a minicsavar, hogyan helyezzük be, és mit érezhet.
✗ Annyira húzzuk hátra a fogakat, amennyire akarjuk.	✓ Hogy mennyire tudjuk hátrébb vinni őket, azt a felvételei határozzák meg.
✗ A foghúzásos megoldás elavult.	✓ Mindkét út megfelelő bizonyos esetekben; beszéljük meg, melyik illik jobban Önhöz.

Megnövekedett overjet, traumakockázat (gyermek)

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Az előreálló fogak ki vannak téve az ütéseknek**

Klinikai keret (az orvosnak): Kifejezett overjet, elégtelen ajakfedés; metszőfog-traumakockázat. Korai beavatkozás (készülék vagy korlátozott kezelés) és védőintézkedések jönnek szóba.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke felső elülső fogai jól láthatóan előrébb állnak, és az ajkai nem tudják teljesen fedni őket. Ilyenkor esés vagy ütközés során nagyobb a kockázata, hogy az elülső fogak megsérülnek. Ezért az időzítést nemcsak a megjelenés, hanem a fogak védelme szempontjából is át kell gondolnunk. Egyes gyermekeknél a korán elkezdett készülékes kezelés javíthatja az elülső fogak helyzetét, és csökkentheti ezt a kockázatot. Ha sportol, fontos, hogy fogvédőt használjon. A korai kezelés nem mindig teszi feleslegessé a későbbi második kezelési szakaszt; szeretném, ha ezt már az elején tudná. Jegyezzük fel azt is, hogy ha valamelyik elülső fogát ütés éri, haladéktalanul forduljanak fogorvoshoz.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A korai készülékes kezelés célja, hogy javítsa az elülső fogak helyzetét, és támogassa az állcsontok közötti viszonyt. A viselési idő betartása közvetlenül befolyásolja az eredményt; készíthetünk együtt egy követőtáblázatot.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A fogai bármikor eltörhetnek.	✓ Az elülső fogak jobban ki vannak téve az ütéseknek; beszéljük meg, hogyan csökkenthetjük a kockázatot.
✗ Ha korán kezdjük, nem lesz második kezelés.	✓ A korai kezelés csökkentheti a kockázatokat; később második szakaszra is szükség lehet.
✗ Ne engedje sportolni.	✓ Nyugodtan sportolhat tovább; javaslom, hogy viseljen fogvédőt.

4. FEJEZET

III. osztályú esetek

Pszeudo-, valódi csontos és sebészi határesetű III. osztály; a növekedés őszinte bemutatása.

> *Ebben a fejezetben a 17–21. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.*

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
17	Pszeudo-III. osztály (gyermek)	Szülő	Előrecsúszásból eredő fordított harapás; a korai korrekció logikája
18	Valódi csontos III. osztály (gyermek)	Szülő	A korai ortopédia esély; az eredmény a növekedéstől függ
19	III. osztály, serdülő, növekedéskövetés	Serdülő és szülő	Amíg tart a növekedés, a döntés halasztható
20	III. osztály, felnőtt, kompenzáció	Páciens (felnőtt)	A fogak összehangolása lehetséges; az arc változása korlátozott
21	III. osztály, sebészi határeset	Páciens (felnőtt)	A sebészi lehetőség őszintén, nyomás nélkül

Pszeudo-III. osztály (gyermek)

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Előrecsúszásból eredő fordított harapás; a korai korrekció logikája**

Klinikai keret (az orvosnak): Frontális fordított harapás; centrikus relációban él-él metszőérintkezés érhető el. Funkcionális előrecsúszás; a korai korrekció általában szóba jön.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke alsó elülső fogai záráskor a felső elülső fogak elé kerülnek. A vizsgálaton láttuk, hogy amikor lassan zárja az állkapcsát, az elülső fogak él-él helyzetbe tudnak kerülni. Ebből arra gondolunk, hogy a probléma nagy része a fogak helyzetéből és abból ered, hogy az alsó állcsont záráskor előrecsúszik. Ilyen esetekben általában korai korrekciót javaslunk, mert ha a fordított harapás megmarad, a fogak és a környező szövetek is károsodhatnak. A kezelés legtöbbször rövid ideig tart, és egyszerű készülékekkel történik. Gyermeke növekedését ennek ellenére kontrollokon követni fogjuk, mert látni szeretnénk, hogyan változik a kép a növekedés során. Ha kérdése van, beszéljük meg most.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Az általunk használt készülék célja, hogy a felső elülső fogakat kissé előre tolja, így azok az alsó fogak elé kerüljenek. Néha a hátsó fogakra ideiglenes harapásemelőt teszünk; ez azért kell, hogy az elülső fogak szabadon mozoghassanak.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ez egyszerű, utána soha nem lesz gond.	✓ A kezelés általában rövid; a növekedést ettől függetlenül kontrollokon követjük.
✗ Kiugrik az álla.	✓ Az alsó állcsont záráskor előrecsúszik; elmondom, mi ennek az oka.
✗ Várhatunk is vele.	✓ Az ilyen fordított harapásnál általában korai korrekciót javaslunk; elmagyarázom, miért.

Valódi csontos III. osztály (gyermek)

Kinek: Szülő **Fő üzenet: A korai ortopédia esély; az eredmény a növekedéstől függ**

Klinikai keret (az orvosnak): Csontos III. osztályú jelek, a felső állcsont fejlődése elmarad; növekedésben lévő gyermek. RME és arcmaszk lehetősége; a családi anamnézist és a növekedés irányát fel kell mérni.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«A felvételeken látjuk, hogy gyermeke felső állcsontja elmarad az alsóhoz képest. Ez a fogakon túl az állcsontok fejlődésével függ össze. A növekedés időszakában használhatunk olyan ortopédiai készülékeket, amelyek a felső állcsont fejlődését támogatják. Ilyen lehet egy, a felső állcsontot tágító készülék és egy főként éjszaka viselt arcmaszk. Van valami, amit őszintén el kell mondanom: az ilyen esetekben a növekedés a következő években is folytatódik, és hogy az eredmény mennyire lesz tartós, az a növekedés irányától függ. Ezért rendszeresen követjük, és később kiegészítő kezelésre, sőt a növekedés befejeztével állcsontsebészetre is szükség lehet. Azt is szeretném megtudni, előfordult-e hasonló a családban.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A tágítókészüléket a felső szájpadhoz rögzítjük; a megmutatott módon, meghatározott időközönként kell csavarni. Az arcmaszkot inkább otthon és éjszaka használják. A rendszeres viselés közvetlenül befolyásolja az eredményt. Tervezzük meg együtt, mely órákban viselje.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A maszkkal teljesen rendbe jön az állkapcsa.	✓ A felső állcsont fejlődésének támogatása a célunk; a növekedést évekig követjük.
✗ Ha korán kezdjük, biztosan nem kell műtét.	✓ A korai kezelés lehetőség; tudnia kell, hogy később műtétre is szükség lehet.
✗ Ha nem hordja a maszkot, nem használ; az Ön döntése.	✓ Készítsünk együtt tervet, hogy gyermeke megszokja a maszkot.

III. osztály, serdülő, növekedéskövetés

Kinek: Serdülő és szülő **Fő üzenet: Amíg tart a növekedés, a döntés halasztható**

Klinikai keret (az orvosnak): Serdülő; enyhe-közepes csontos III. osztályú tendencia, a növekedés folytatódik. A korai kompenzáció kockázatos lehet; a megfigyelés és a növekedés végén történő értékelés lehetőség.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felvételeken látjuk, hogy az alsó állcsont a felsőhöz képest kissé előrébb van. Mivel a növekedése még tart, nem tudhatjuk pontosan, hogyan változik ez a viszony a következő években; az alsó állcsont növekedése néha a serdülőkor végéig is eltarthat. Ezért ahelyett, hogy most végleges döntést hoznánk, olyan korlátozott kezelést vagy kontrollált megfigyelést javasolhatok, amely rendben tartja a fogakat. Amikor a növekedés lelassul, újra felvételeket készítünk, és értékeljük, hogy csak fogszabályozással haladunk-e tovább, vagy az állcsontsebészet is lehetőség. Ez a várakozási idő nem elvesztegetett idő; szükséges ahhoz, hogy helyes döntést hozhassunk. Az Ön és a családja véleménye is fontos számomra.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A mostani szakaszban alkalmazott kezelés a fogak elrendeződésének és a harapásnak a kezelésére irányul. A fő döntést akkor hozzuk meg, amikor a növekedés lelassulásakor újra felvételeket készítünk. Ezt a tervet írásban is átadom Önnek.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha megnő, megműtjük.	✓ Amikor a növekedés lelassul, újraértékeljük a lehetőségeket.
✗ Ha most felrakjuk a fogszabályozót, nem marad gond.	✓ Amíg tart a növekedés, egyes eredmények változhatnak; ezért követjük.
✗ A várakozással csak időt vesztünk.	✓ Ez a megfigyelési időszak a helyes döntés szükséges szakasza.

III. osztály, felnőtt, kompenzáció

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: A fogak összehangolása lehetséges; az arc változása korlátozott**

Klinikai keret (az orvosnak): Felnőtt; enyhe-közepes csontos III. osztály, a kompenzációnak megfelelő határokon belül. Alsó metszők hátrahúzása, felső metszők előrehozása; az íny és a csont határait figyelembe kell venni.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az alsó állcsontja a felsőhöz képest kissé előrébb van. Mivel a növekedése befejeződött, ezt a viszonyt készülékekkel már nem tudjuk megváltoztatni; a különbség mértéke azonban alkalmasnak tűnik arra, hogy a fogak helyzetének beállításával korrigáljuk a harapást. Ebben a tervben a felső elülső fogakat kissé előre, az alsó elülső fogakat kissé hátra kívánjuk irányítani. Ennek van határa: a fogak csak annyira mozdulhatnak el, amennyire a csont és az íny alátámasztása engedi. Ezért nem tartanám helyesnek, ha nagy változást várna az arcprofiljában. Ha a profil az elsődleges szempont, külön beszélhetünk az állcsontsebészettel kombinált kezelés lehetőségéről is. Határozzuk meg együtt, melyik felel meg az elvárásainak.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ebben a tervben néha az alsó állcsontban a helynyeréshez foghúzásra vagy kiegészítő lehorgonyzásra, például minicsavarra lehet szükség. Emellett az állcsontok közé akasztott elasztikusokat is használunk. Mindegyiknek elmondom az okát, és lépésről lépésre megmutatom a használatát.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Hátrébb hozzuk az állkapcsát.	✓ A fogak helyzetét igazítjuk az állcsontokhoz; az állcsont helyzete nem változik.
✗ A profilja is rendbe jön.	✓ A profil változása korlátozott lehet; tisztázzuk az elvárásainkat.
✗ A műtét felesleges.	✓ A műtét bizonyos páciensek számára a helyes lehetőség; ha szüksége lesz rá, tájékoztatom.

III. osztály, sebészi határeset

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: A sebészi lehetőség őszintén, nyomás nélkül**

Klinikai keret (az orvosnak): Kifejezett csontos III. osztály, esetleges aszimmetria; a kompenzáció határán vagy azon túl. Ortognát sebészettel kombinált kezelést kell mérlegelni; szájsebészeti konzultáció.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felvételein látjuk, hogy az alsó és a felső állcsont közötti különbség meglehetősen kifejezett. Ha ekkora különbséget csupán a fogak mozgatásával próbálnánk kiegyenlíteni, az a fogakat a csontos alátámasztás határaira kényszeríthetné, és az arca megjelenését alig változtatná meg. Ezért olyan tervet is szeretnék Önnek bemutatni, amely a fogszabályozást állcsontsebészettel kombinálja. Ez nem kötelező, hanem lehetőség. A műtétnek van előkészítő szakasza, kórházi része és gyógyulási időszaka; a kockázatait és előnyeit a szájsebész szakorvosnak részletesen el kell magyaráznia. Ha nem szeretne műtétet, nyíltan megbeszéljük azt is, mit nyújthat egy korlátozott fogszabályozó terv. Fontos, hogy sietség nélkül gondolja át.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A kombinált tervben a fogszabályozás a műtét előtt kezdődik, és felkészíti a fogakat az állcsontműtétre. Ebben az időszakban a harapás átmenetileg hangsúlyosabbnak tűnhet. A műtét után rövid fogszabályozó befejező szakasz következik. Készüljünk fel együtt a szakorvosi konzultációra.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Az egyetlen megoldás a műtét.	✓ A sebészettel kombinált terv egy lehetőség; a műtét nélküli terv határait is elmondom.
✗ A műtét nagyon könnyű, ne féljen.	✓ A műtét folyamatát és kockázatait a szakorvosnak részletesen el kell magyaráznia.
✗ Azonnal döntenie kell.	✓ Fontos, hogy sietség nélkül, tájékozódva döntsön.

5. FEJEZET

Vertikális és Transzverzális Problémák

Nyitott harapás, mélyharapás, kereszharapás és ollós harapás.

Ebben a fejezetben a 22–28. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
22	Frontális nyitott harapás, gyermek (szokás)	Szülő és gyermek	Először a szokás, utána a fogak
23	Frontális nyitott harapás, felnőtt	Páciens (felnőtt)	Többtényezős ok; a recidívahajlam nyíltan
24	Mélyharapás	Páciens vagy szülő	A túlzott fedés terheli a fogakat és az ínyt
25	Egyoldali hátsó kereszharapás (gyermek)	Szülő	Szűk felső állcsont és oldalra csúszás; korai korrekció
26	Szűk felső állcsont, felnőtt	Páciens (felnőtt)	Ha a varrat elcsontosodott, mások a lehetőségek
27	Egyfogas frontális kereszharapás	Páciens vagy szülő	Beékelődött fog; korai megoldás a fog és az íny érdekében
28	Ollós harapás	Páciens	Kifelé kitérő hátsó fogak; részletes terv

Frontális nyitott harapás, gyermek (szokás)

Kinek: Szülő és gyermek **Fő üzenet: Először a szokás, utána a fogak**

Klinikai keret (az orvosnak): Frontális nyitott harapás vegyes fogazatban; ujjszopás, cumi vagy nyelvlökés az anamnézisben. A szokás elhagyása és szükség esetén szokásleszoktató készülék.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK / A SZÜLŐNEK

«Amikor gyermeke összezárja a fogait, az elülső fogak nem érnek össze; rés marad közöttük. Ebben a korban ez legtöbbször ujjszopással, ajak- vagy nyelvszokással függ össze. Az első és legfontosabb lépés, hogy a szokás csökkenjen. Amíg a szokás fennáll, a kezelésünk hatása korlátozott maradhat. Ezt sokkal eredményesebb úgy elérni, ha nem hibáztatjuk a gyermeket, hanem jutalmazzuk és támogatjuk. Szükség esetén egy egyszerű, a szokásra emlékeztető készüléket is használhatunk. Egyes gyermekeknél a szokás megszűnése után a rés magától csökkenhet, másoknál kiegészítő kezelés kell. Ha a beszéddel vagy a nyeléssel kapcsolatos problémát észlel, azt is értékelhetjük együtt.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A szokásleszoktató készülék egy kis eszköz, amely megnehezíti, hogy a nyelv vagy az ujj nyomja az elülső fogakat. Nem büntetés; emlékeztetőként kell bemutatni a gyermeknek. Az első napokban a beszéd és az evés megszokást igényelhet.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha nem hagyja abba az ujjszopást, elromlanak a fogai.	✓ Ahogy a szokás csökken, a kezelés jobban működik; támogassuk együtt.
✗ Ez a készülék büntetés, hogy ne szopja az ujját.	✓ Ez a készülék emlékeztető.
✗ Magától rendbe jön.	✓ Egyes gyermekeknél csökkenhet; kontrollokon követjük.

Frontális nyitott harapás, felnőtt

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Többtényezős ok; a recidívahajlam nyíltan**

Klinikai keret (az orvosnak): Frontális nyitott harapás felnőttnél; lehetséges tényezők: vertikális csontos növekedési irány, nyelvhelyzet, légzési anamnézis. Mechanikai lehetőségek: minicsavarral támogatott intrúzió, extrúzió, sebészet.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Amikor összezárja a fogait, az elülső fogai nem érnek össze. Felnőttkorban ennek általában több oka van: az állcsontok vertikális felépítése, a nyelv nyugalmi helyzete vagy korábbi szokások. A kezelés célja, hogy az elülső fogak érintkezzenek, és javuljon a harapás funkciója. Ehhez több lehetőség van: a hátsó fogak enyhe intrúziója, az elülső fogak enyhe extrúziója, vagy nagy eltérés esetén a kombináció állcsontsebészettel. Szeretném nyíltan elmondani, hogy az ilyen harapás a kezelés után részben hajlamos visszatérni. Ezért a retenció és szükség esetén a nyelvszokás kezelése is a terv része lesz. Beszéljük meg együtt, melyik lehetőség reális az Ön számára.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A hátsó fogak kismértékű intrúziójához minicsavarokat használhatunk lehorgonyzásként. Ezek a fogak közé behelyezett kis, ideiglenes csavarok, amelyeket a kezelés végén eltávolítunk. A felvételeken megmutatom, melyik területre és miért kerülnek.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ez a harapás, ha egyszer rendbe jött, végleges.	✓ A nyitott harapás hajlamos lehet visszatérni; ezért fontos a retenció.
✗ A nyelve miatt alakult ki.	✓ A nyelv helyzete hozzájárulhat; a többi okot is együtt értékeltük.
✗ Nem kell műtét, ne aggódjon.	✓ Az eltérés nagyságától függően a sebészi lehetőséget is meg kell beszélnünk.

Mélyharapás

Kinek: Páciens vagy szülő **Fő üzenet: A túlzott fedés terheli a fogakat és az ínyt**

Klinikai keret (az orvosnak): Kifejezett overbite; az alsó metszők a szájpadi nyálkahártyához vagy a felső metszők palatinális felszínéhez érnek. A Spee-görbe mély lehet. Metszőfog-intrúzió, hátsó extrúzió lehetősége.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Amikor összezárja a fogait, a felső elülső fogak a szükségesnél jobban fedik az alsó elülső fogakat. Néha az alsó fogak olyan mélyen záródnak, hogy a szájpadhoz vagy a felső fogak belső felszínéhez érnek. Ez idővel fogkopáshoz, a szájpad érzékenységéhez vagy az elülső fogak helyzetének változásához vezethet. A kezelés célja, hogy csökkentsük a harapás mélységét, és kiegyensúlyozzuk az elülső fogak közötti érintkezést. Ehhez olyan módszereket alkalmazunk, mint az elülső fogak kismértékű intrúziója, a hátsó fogak záródásának beállítása vagy a kettő kombinációja. A mélyharapás a kezelés után hajlamos lehet visszatérni; ezért a retenciós szakaszt már az elejétől megtervezzük. Ha vannak zavaró tünetei, először azokat szeretném meghallgatni.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Egyes esetekben a hátsó fogakra vagy a felső elülső fogak belső felszínére kis harapásemelőket ragasztunk. Ezek átmenetileg csökkentik a fogak záródását. Az első napokban rágáskor szokatlan lehet az érzés; ezt általában hamar megszokják.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Az alsó fogai felsértik a szájpadját.	✓ Az alsó fogak a szájpadhoz közel záródnak; beszéljünk egy tervről, amely ezt csökkenti.
✗ A mélyharapás magától nem javul, azonnal kezdenünk kell.	✓ Értékeljük együtt ennek a harapásnak a hatásait és az időzítést.
✗ A retenció csak néhány hónap.	✓ Mélyharapásnál a retenció idejét hosszúra tervezzük.

Egyoldali hátsó keresztharapás (gyermek)

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Szűk felső állcsont és oldalra csúszás; korai korrekció**

Klinikai keret (az orvosnak): Egyoldali hátsó keresztharapás, többnyire szűk felső állcsonttal és záráskor fellépő mandibuláris oldalcsúszással. Növekedési időszakban RME lehetősége.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Amikor gyermeke összezárja a fogait, az egyik oldalon a hátsó fogak fordítva záródnak, és az alsó állcsont arra az oldalra csúszik. Ennek oka legtöbbször az, hogy a felső állcsont kissé szűk. A növekedés időszakában a felső állcsont tágítására használt készülékek ebben a korban általában jó eredményt adnak, mert a felső állcsont közepén lévő növekedési varrat még nem csontosodott el. Ha ez az oldalra csúszás hosszú ideig fennáll, befolyásolhatja az állcsontfejlődés egyensúlyát; ezért korai korrekciót javaslok. A kezelés tágítási szakasza általában rövid; utána a készülék egy ideig a szájban marad, hogy megőrizzük az elért szélességet. Ha szájlégzést vagy horkolást észlelt, azt is szeretném feljegyezni.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A tágítókészüléket a felső szájpadhoz rögzítjük, és a megmutatott módon kell csavarni. Az első csavarásoknál nyomásérzés lehet az orr és a szájpad környékén. Az elülső fogak között átmeneti rés nyílhat; ez várható, és később bezárul.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ferdén nő az állkapcsa.	✓ Az alsó állcsont záráskor egyik oldalra csúszik; elmondom, hogyan korrigálható.
✗ Egyáltalán nem fáj.	✓ Az első napokban nyomásérzés lehet; ez általában rövid ideig tart.
✗ A fogak között nyíló rés probléma.	✓ Az elülső fogak közötti átmeneti rés megnyílása várható jelenség.

Szűk felső állcsont, felnőtt

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Ha a varrat elcsontosodott, mások a lehetőségek**

Klinikai keret (az orvosnak): Kétoldali hátsó kereszttharapás felnőttnél, szűk felső állcsont. Értékelendő: a dentális tágítás határai, minicsavarral támogatott tágítás vagy sebészileg segített tágítás.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső állcsontja az alsóhoz képest szűk, ezért a hátsó fogai mindkét oldalon fordítva záródnak. Gyermekeknél a tágítás könnyebb, mert a felső állcsont középvarrata még nem csontosodott el. Felnőttkorban ez a varrat nagyrészt elcsontosodott, ezért a lehetőségek mások. Enyhe szűkületnél a fogak kontrollált kifelé döntésével korlátozott szélességet nyerhetünk, de ennek az íny és a csont alátámasztása szempontjából határa van. Kifejezett szűkületnél csontra támaszkodó tágítás vagy sebészileg segített tágítás jöhet szóba. Ma elmondom, melyik út reális az Ön helyzetében, és mit igényel mindegyik. Az íny egészségét az egész folyamat során szorosan követjük.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A csontra támaszkodó tágításnál a készülék a fogak mellett a szájpadba helyezett kis csavarokra támaszkodik. A sebészileg segített tágításnál a tágítás előtt egy kisebb sebészi beavatkozást végzünk. Ezeket a lehetőségeket az illetékes szakorvossal közösen értékeljük.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Fogszabályozóval kitágítjuk, megoldjuk.	✓ Felnőttkorban a tágításnak határai vannak; beszéljük meg nyíltan a lehetőségeket.
✗ Bárcsak gyerekként hozták volna.	✓ Határozzuk meg együtt a mostani helyzetéhez legjobban illő utat.
✗ Az ínyének nem lesz baja.	✓ Az íny egészségét a kezelés során szorosan követjük.

Egyfogas frontális keresztharapás

Kinek: Páciens vagy szülő **Fő üzenet: Beékelődött fog; korai megoldás a fog és az íny érdekében**

Klinikai keret (az orvosnak): Egyetlen felső metsző az alsó mögé záródik; esetleges ínyrecesszió vagy zománckopás. A csontos viszony általában normális. Korrekció egyszerű mechanikával.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az egyik felső elülső foga záráskor az alsó fog mögött marad. Mivel a többi foga normális viszonyban van, úgy gondoljuk, hogy a probléma nem az állcsont felépítéséből, hanem annak a fognak a helyzetéből ered. Ha ez fennmarad, az alsó fognál ínyhúzódáshoz vagy mindkét fog kopásához vezethet. Ezért azt javaslom, ne halassza a korrekciót. Az ilyen egyfogas problémák legtöbbször korlátozott kezeléssel korrigálhatók; meg kell azonban vizsgálnunk, van-e elég hely a fog előrehozásához. Ha nincs elég hely, előbb helyet kell nyitnunk. A kezelés után retenciót tervezünk, hogy a fog ne csússzon vissza befelé.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A fog előrehozásához kis készüléket vagy korlátozott rögzített kezelést használhatunk. Hogy a fog akadás nélkül mozoghasson, a hátsó fogakra ideiglenes harapásemelő kerülhet.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Egy foga fordítva áll, nem számít.	✓ Ez a fog idővel hatással lehet az ínyre és a zománcra; korai korrekciót javaslok.
✗ Két hét alatt rendbe hozzuk.	✓ Az időtartam a helyviszonyoktól függ; a kontrollokon pontosítjuk.
✗ Nincs szükség retencióra.	✓ Retenciót tervezünk, hogy a fog ne csússzon vissza befelé.

Ollós harapás

Kinek: Páciens **Fő üzenet: Kifelé kitérő hátsó fogak; részletes terv**

Klinikai keret (az orvosnak): A felső hátsó fog(ak) az alsó fogaktól bukkálisan helyezkednek el, érintkezés nincs; egy fog vagy szegmens. Értékelendő: fogtengely-dőlés, extrúzió és lehorgonyzási igény; minicsavarral támogatott mechanika lehetősége.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Néhány hátsó foga záráskor nem a szemben lévő foggal találkozik, hanem annak külső oldala mellett halad el. Ilyenkor ezek a fogak nem vesznek részt teljesen a rágásban, és idővel a kelleténél jobban kinyúlhatnak. A kezelés célja, hogy ezeket a fogakat helyes viszonyba hozzuk a szemben lévő fogaikkal. Ehhez a fogat befelé kell dönteni, szükség esetén kissé intrudálni, és a szemben lévő fogat is megfelelő helyzetbe kell hozni. Egyes esetekben, hogy ezeket a mozgásokat nem kívánt mellékhatások nélkül végezzük, ideiglenes eszközöket, például minicsavart vagy keresztelasztikusokat használunk. Ha a probléma egy fogra korlátozódik, a kezelés rövidebb lehet; ha több fog érintett, a terv átfogóbb. Ezt a felvételeken megmutatom Önnek.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A keresztelasztikusok olyan gumik, amelyeket a felső és alsó fogakra ragasztott kis gombok közé akasztunk. Ezeket minden nap Ön cseréli. Az első napokban rágáskor érzékenység lehet.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ezek a fogak teljesen rosszul állnak.	✓ Ezek a fogak nem érintkeznek teljesen a szemben lévő fogakkal; elmondom, hogyan korrigálható.
✗ Elég, ha néha felrakja az elasztikusokat.	✓ Az elasztikusok rendszeres viselése szükséges ahhoz, hogy a mozgás létrejöjjön.
✗ Nagyon gyorsan rendbe jön.	✓ Az időtartam az érintett fogak számától függ; nézzük meg együtt a felvételeken.

6. FEJEZET

Fogszám és fogpozíció

Retineált, hiányzó, számfeletti és ankilotikus fogak; helyvesztés.

Ebben a fejezetben a 29–34. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
29	Retineált felső szemfog	Páciens vagy szülő	Sebészi feltárás és a fog helyére vezetése
30	Veleszületetten hiányzó felső oldalsó metsző	Páciens vagy szülő	Helynyitás vagy résbezárás?
31	Korai tejfogvesztés, helytartó	Szülő	Az elvesztett hely nehezen nyerhető vissza
32	Hiányzó fog felnőttnél, implantáció előtti fogszabályozás	Páciens (felnőtt)	A helyelőkészítés multidiszciplináris feladat
33	Számfeletti fog (meziodens) vagy át nem tört metsző	Szülő	Az akadály eltávolítása nélkül a fog nem tör át
34	Ankilózis gyanújú tejfog	Szülő	A fog összenőhetett a csonttal; megfigyelés és időzítés

Retineált felső szemfog

Kinek: Páciens vagy szülő **Fő üzenet: Sebészi feltárás és a fog helyére vezetése**

Klinikai keret (az orvosnak): A felső szemfog retineált, vagy az áttörési útja eltért; helyzetét háromdimenziós képalkotással is meghatározhatták. Lehetőségek: a tejszemfog eltávolítása és megfigyelés, sebészi feltárás + ortodonciai trakció, ritkán extrakció.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felső szemfoga nem tudott magától áttörni, és a csontban maradt. A felvételeken megvizsgáltuk, hol helyezkedik el a fog, és mennyire van közel a szomszédos fogak gyökereihez. Ezt a fogat legtöbbször a helyére lehet vezetni, ehhez azonban a szájsebésznek fel kell tárnia a fog feletti területet, és egy kis gombot kell a fogra ragasztania. Ezután a fogat a készülékkel lassan és kontrolláltan a helyére húzzuk. Ez a folyamat tovább tarthat, mint a többi fog rendezése. A fog helyzetétől függően más lehetőségek is lehetnek; néha elég csak a tejfogat eltávolítani, és egy ideig megfigyelni. A felvételek alapján megmutatom, melyik út a megfelelő.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A sebészi feltárást a szájsebész végzi érzéstelenítésben. Utána néhány napig érzékenység lehet. A fogra ragasztott kis gomb segítségével lassan a helyére irányítjuk a fogat. Amíg a fog a helyére nem kerül, fontos a rendszeres kontroll.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ezt a fogat biztosan a helyére hozzuk.	✓ Az esetek többségében lehetséges; a foga helyzete alapján elmondom a lehetőségeket.
✗ A szomszédos fog gyökere felszívódott.	✓ A felvételeken értékeltük a szomszédos foghoz való viszonyt; nézzük meg együtt, mit láttunk.
✗ Csak egy kis bemetszés, semmiség.	✓ A sebészi feltárás beavatkozás; a szájsebész részletesen tájékoztatja.

Veleszületetten hiányzó felső oldalsó metsző

Kinek: Páciens vagy szülő | Fő üzenet: Helynyitás vagy résbezárás?

Klinikai keret (az orvosnak): Egy vagy két felső oldalsó metsző agenesiája. Lehetőségek: a rés bezárása és a szemfog oldalsó metsző formájúvá alakítása, vagy a hely megtartása és később protetikai/implantációs megoldás.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«A felvételeken látjuk, hogy az egyik oldalsó elülső foga egyáltalán nem fejlődött ki. Ilyenkor két fő út van. Az első a rés bezárása: a szemfogat a résbe vezetjük, és formáját tömőanyaggal vagy kisebb korrekciókkal az oldalsó metszőhöz hasonlóvá alakítjuk. A második, hogy a rést megfelelő szélességben megtartjuk, és később fogpótlást tervezünk erre a helyre. A második útnál a végleges megoldás általában a növekedés befejezése után készül; addig ideiglenes megoldást használunk. Hogy melyik út a megfelelő, az a harapástól, a szemfog formájától és színétől, a mosolyvonaltól és az Ön választásától függ. Mindkét esetben a fogorvosával vagy a protetikus szakorvossal közösen dolgozunk.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A helymegtartó megoldásnál a rést a később elkészülő fog számára megfelelő szélességben tartjuk. Ebben az időszakban esztétikai okból ideiglenes fog is használható. A végleges megoldás időpontját a növekedés befejeztével határozzuk meg.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Beültetünk egy implantátumot, egyszerű.	✓ Később fogpótlás készülhet erre a helyre; tervezzük meg együtt az időzítését és a feltételeit.
✗ Ha bezárjuk, senki sem veszi észre.	✓ A szemfog formája és színe befolyásolja az eredményt; beszéljük meg az előnyöket és hátrányokat.
✗ Mindegy, melyik utat választjuk.	✓ A két út között különbség van a gondozás, az időtartam és az esztétika szempontjából.

Korai tejfogvesztés, helytartó

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Az elvesztett hely nehezen nyerhető vissza**

Klinikai keret (az orvosnak): Tejőrlőfog korai elvesztése (szuvasodás vagy extrakció); a maradó fog áttöréséig még idő van hátra. Helytartóval történő helymegtartás jön szóba.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke egyik tejőrlőfoga elveszett, mielőtt az alatta lévő maradó fog előbújt volna. Ennek a fognak az volt a feladata, hogy a maradó fog megjelenéséig megtartsa a helyet. Ha a rést nem tartjuk meg, a szomszédos fogak elvándorolhatnak a helyére, és szűkülhet a maradó fog helye. Ez később torlódáshoz vagy a fog retineálódásához vezethet. Ennek megelőzésére egy egyszerű készüléket, úgynevezett helytartót javaslok. Ez a készülék a maradó fog áttöréséig megőrzi a rést, és a kontrollokon követjük. Amikor a maradó fog elkezd áttörni, eltávolítjuk a készüléket. Ebben az időszakban a többi tejfog szuvasodás elleni védelme legalább olyan fontos, mint maga a készülék.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A helytartó kis készülék, amely a szomszédos foghoz rögzül vagy a szájpadra támaszkodik. A legtöbb gyermek rövid idő alatt megszokja a rágás és a beszéd során. Ha kerülik a ragacsos és kemény ételeket, a készülék nem mozdul el.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ha elveszik ez a hely, a foga soha nem bújik elő.	✓ Ha a helyet nem tartjuk meg, nehezebb lehet a maradó fog áttörése; ezért javaslok helytartót.
✗ A tejfog úgyis kiesett volna.	✓ A tejfog helyet tartott a maradó fognak; ezt a feladatot most a készülék veszi át.
✗ A helytartó egy életen át marad.	✓ Amikor a maradó fog elkezd áttörni, eltávolítjuk.

Hiányzó fog felnőttnél, implantáció előtti fogszabályozás

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: A helyelőkészítés multidiszciplináris feladat**

Klinikai keret (az orvosnak): Felnőtt; az eltávolított fog helyére a szomszédos fogak bedőltek, az antagonista elongálódott. A fogak felegyenesítése és a hely rendezése protetikai/implantációs kezelés előtt.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Egy évekkel ezelőtt eltávolított fog helyére a szomszédos fogai bedőltek, és a szemközti állcsontban lévő fog kissé kinyúlt. Ezért nehezebb erre a helyre megfelelő fogpótlást készíteni. A fogszabályozással itt olyan teret készíthetünk elő, amelyben a protetikus vagy implantológus kollégája dolgozni tud. A célunk, hogy felegyenesítsük a bedőlt fogakat, a rést megfelelő szélességűre állítsuk, és javítsunk a szemközti fog helyzetén. Ez legtöbbször korlátozott kezelés, amely nem érinti az egész fogazatot. A tervet a kezelő másik orvossal közösen készítjük el, így a fogszabályozás befejezése és a protetikai szakasz között nem lesz kiesés. Az íny egészségét is követjük a folyamat során.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ebben a kezelésben elég lehet csak az érintett területre bracketet vagy kis eszközöket felhelyezni. Néha minicsavart használunk lehorgonyzásként, hogy a fogakat a kívánt irányba mozgassuk. A végén közösen ellenőrizzük, hogy a terület készen áll-e a protetikus kolléga számára.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Azért lett ilyen, mert kihúzatta ezt a fogat.	✓ Idővel a szomszédos fogak bedőltek a résbe; ez korrigálható.
✗ A fogszabályozás után biztosan lesz implantátum.	✓ A megfelelő terület előkészítése a célunk; az implantációról az illetékes orvos dönt.
✗ Minden fogra készülék kell.	✓ Legtöbbször korlátozott kezelés is elég lehet; készítsük el együtt a tervet.

Számfeletti fog (meziodens) vagy át nem tört metsző

Kinek: Szülő **Fő üzenet: Az akadály eltávolítása nélkül a fog nem tör át**

Klinikai keret (az orvosnak): Számfeletti fog a felső középső régióban; akadályozza a maradó metsző áttörését, vagy diasztémát okoz. Sebészi eltávolítás, megfigyelés, szükség esetén helynyitás és trakció.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«A felvételeken látjuk, hogy gyermeke felső elülső régiójában van egy számfeletti fog. Ez a fog akadályozhatja a maradó elülső fog előbújását, vagy rést okozhat az elülső fogak között. A számfeletti fogat általában a szájsebész távolítja el. Az eltávolítás után egy ideig követjük, hogy a maradó fog magától áttör-e. Egyes esetekben a fog magától előbújik, máskor helyet kell nyitni, és fogszabályozással kell a helyére vezetni. A folyamat lépéseit és a kontrollok időpontjait írásban átadom Önnek. Szeretném gyermekének is a korának megfelelően elmagyarázni a dolgot, hogy ne aggódjon a folyamat során.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A számfeletti fog eltávolítása érzéstelenítésben végzett rövid sebészi beavatkozás. Utána néhány hétig vagy hónapig követjük a maradó fog áttörését. Szükség esetén a következő szakaszban korlátozott kezeléssel a helyére irányítjuk a fogat.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ez a fog rendellenesség.	✓ A számfeletti fog előforduló állapot; lépésről lépésre elmondom, mit teszünk.
✗ Ha eltávolítjuk, a fog azonnal előbújik.	✓ Az eltávolítás után egy ideig követjük a maradó fog áttörését.
✗ A műtét apróság, semmi gond nem lesz.	✓ Rövid beavatkozásról van szó; a szájsebész részletesen tájékoztatja.

Ankilózis gyanújú tejfog

Kinek: Szülő **Fő üzenet: A fog összenőhetett a csonttal; megfigyelés és időzítés**

Klinikai keret (az orvosnak): A tejőrlőfog a szomszédaihoz képest lejjebb maradt (infraokklúzió), kopogtatásra eltérő hangot adhat. Követendő: az alatta lévő maradó fog megléte, a progresszió üteme és a szomszédos fogak dőlése.

MIT MONDJUNK A SZÜLŐNEK

«Gyermeke egyik tejőrlőfoga a mellette lévő fogakhoz képest lejjebb maradtnak látszik. Ez általában azzal függ össze, hogy a fog gyökerei összenőttek a környező csonttal. Az ilyen fog az állcsont növekedése során nem tud együtt emelkedni a többi foggal, és idővel még lejjebb kerülhet. Ha alatta van maradó fog, és a folyamat lassú, elég lehet egy ideig megfigyelni. Ha azonban a szomszédos fogak elkezdenek ráborulni, vagy nő a különbség, felmerülhet a fog eltávolítása és a hely megtartása. Ha nincs alatta maradó fog, más a terv; ezt külön kell megbeszélnünk. Ezt a fogat a rendszeres kontrollokon méréssel követjük.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ha eltávolításra van szükség, utána a rés megtartására helytartót használhatunk. Ha nincs alatta maradó fog, közösen értékeljük az olyan lehetőségeket, mint a tejfog egy ideig való megtartása vagy a rés tervszerű kezelése.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Ez a fog elhalt.	✓ A fog gyökere összenőhetett a csonttal; ezt a kontrollokon követjük.
✗ Azonnal ki kell húznunk.	✓ Az alatta lévő maradó fog és a progresszió üteme alapján döntünk.
✗ Magától rendbe jön.	✓ Ez a fog általában magától nem emelkedik fel; rendszeres megfigyelés szükséges.

7. FEJEZET

Felnőttek és különleges helyzetek

Parodontális páciens, átlátszó sín iránti kérés, recidíva, korlátozott kezelés és állkapocsízületi panasz.

Ebben a fejezetben a 35–40. eset található. Keresd meg az esetet a táblázatban, és nyisd meg a hozzá tartozó oldalt.

SZ.	ESETTÍPUS	KINEK	FŐ ÜZENET
35	Felnőtt parodontális páciens	Páciens (felnőtt)	Először az íny egészsége, utána enyhe erő
36	Átlátszó sínt kérő páciens (alkalmas eset)	Páciens	A kérés megfelelő; az együttműködés feltétele nyíltan
37	Átlátszó sínt kérő páciens (korlátozott eset)	Páciens	Őszinte határ a kérés lekicsinylése nélkül
38	Recidíva: a fogak újra torlódtak	Páciens (felnőtt)	Hibáztatás nélkül az okról és a megoldásról
39	Csak az elülső fogakat kérő felnőtt	Páciens (felnőtt)	A korlátozott kezelés határai legyenek írásban
40	Állkapocsízületi (TMI) panaszos páciens	Páciens	A fogszabályozás nem TMI-kezelés

Felnőtt parodontális páciens

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Először az íny egészsége, utána enyhe erő**

Klinikai keret (az orvosnak): Felnőtt; csontvesztés, az elülső fogak legyezőszerű szétnyílása vagy vándorlása. Előbb parodontális kezelés és stabilizálás; enyhe erők, hosszú távú rögzített retenció.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az íny és a csont alátámasztásában a múltban veszteség történt, és az elülső fogai idővel bekövetkezett elmozdulása nagyrészt ezzel függ össze. A fogszabályozó kezelés segíthet ezeket a fogakat újra sorba rendezni, és megkönnyítheti a tisztításukat. Itt azonban a legfontosabb szabály ez: amíg az ínybetegség nincs kontroll alatt, nem mozgatjuk a fogakat. Először a parodontológusával együtt befejezzük az ínykezelést, és kialakítjuk a rendszeres gondozási programját. A kezelés alatt enyhébb erőket használunk, és gyakori időközönként ellenőrizzük az íny állapotát. Nem ígérhetem, hogy a fogszabályozás visszaadja az elvesztett csontot. A fogak új helyzetének megőrzéséhez általában hosszú távú rögzített retenció szükséges.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ebben a kezelésben bracketek vagy átlátszó sínek is használhatók; a választás az íny állapotától és a tisztítás egyszerűségétől függ. A kezelés alatt a rendszeres ínygondozási időpontjai folytatódnak.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A fogszabályozóval az íny is rendbe jön.	✓ A fogszabályozás megkönnyítheti a tisztítást; az ínykezelés külön folytatódik.
✗ Elhanyagolta az ínyét.	✓ Az íny állapotát közösen tartjuk kontroll alatt.
✗ A csont visszanő.	✓ Nem ígérhetem, hogy visszanyerjük az elvesztett csontot; a meglévő alátámasztás megőrzése a célunk.

Átlátszó sínt kérő páciens (alkalmas eset)

Kinek: Páciens **Fő üzenet: A kérés megfelelő; az együttműködés feltétele nyíltan**

Klinikai keret (az orvosnak): A páciens láthatatlan módszert szeretne; az eset átlátszó sínnel tervezhető. El kell magyarázni a napi viselési időt, a rögzítőelemeket (attachmenteket), az IPR-t és az esetleges köztes korrekciókat.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Az Ön esete alkalmasnak látszik arra, hogy átlátszó sínes kezeléssel tervezzük. Ennél a módszernél egymástól kissé eltérő átlátszó síneket visel, és a fogak lépésről lépésre mozdulnak el. A legfontosabb: az átlátszó sínek csak akkor dolgoznak, amikor a szájában vannak. Ezért az evést és a fogmosást leszámítva a nap nagy részében viselnie kell őket. Egyes fogak felszínére kis, fogszínű kiemelkedéseket ragaszthatunk, hogy a sínek jobban tapadjanak, és szükség esetén a fogak oldalfelszínéről minimális zománcot távolíthatunk el. A kezelés során a terv néha köztes korrekciót igényelhet; ez normális. Utána a rögzítő viselése itt is ugyanúgy kötelező, mint a többi módszernél.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A fogak felszínére ragasztott kis kiemelkedések fogszínűek, és a kezelés végén letisztítva eltávolítjuk őket. A sínek ki- és behelyezését az első alkalommal együtt kipróbáljuk.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Láthatatlan, senki sem veszi észre.	✓ Az átlátszó sínek alig feltűnőek; közelről nézve láthatók.
✗ Akkor hordja, amikor kedve van.	✓ A sínek csak viselés közben dolgoznak; a nap nagy részében a szájban kell lenniük.
✗ Átlátszó sínnel gyorsabban kész.	✓ Az időtartam magától az esettől függ; inkább az együttműködésen múlik, mint a módszeren.

Átlátszó sínt kérő páciens (korlátozott eset)

Kinek: Páciens **Fő üzenet: Őszinte határ a kérés lekicsinylése nélkül**

Klinikai keret (az orvosnak): A páciens átlátszó sínt szeretne; az eset összetett (kifejezett csontos eltérés, retineált fog, súlyos rotációk stb.). Hibrid terv, rögzített kezelés vagy az elvárások kezelése.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Nagyon jól értem, hogy átlátszó sínt szeretne; a megjelenés és a kényelem szempontjából fontos előnyei vannak. Az Ön esetében azonban néhány mozgás, például a kifejezetten elfordult fogak korrekciója vagy az állcsontok közötti viszony megváltoztatása, azok közé tartozik, amelyeket átlátszó sínnel nehéz kiszámíthatóan elvégezni. Ez nem jelenti azt, hogy a módszer rossz; csak azt, hogy az Ön esetében vannak korlátai. Három lehetőséget szeretnék felajánlani: a teljes kezelést rögzített bracketekkel végezzük; a nehéz részt rögzített kezeléssel kezdjük, majd átlátszó sínnel folytatjuk; vagy átlátszó sínnel csak korlátozott javulást tűzünk ki célul. Nyíltan elmondom, mit nyújt és mit nem mindegyik. A döntés az Öné; az én feladatom, hogy őszintén bemutassam a lehetőségeket.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A kerámia vagy fogszínű bracketek is a rögzített kezelés kevésbé feltűnő változatai. A hibrid tervben először rögzített kezeléssel végezzük el a nehéz mozgásokat, utána térünk át az átlátszó sínekre.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Az átlátszó sín Önnek nem jó.	✓ Egyes mozgások átlátszó sínnel nehezek; értékeljük együtt a lehetőségeket.
✗ Megcsináljuk sínnel is, majd meglátjuk.	✓ Beszéljük meg már az elején őszintén, mit érhetünk el a sínnel.
✗ A rögzített készülék úgyis jobb.	✓ Minden módszernek megvannak a megfelelő esetei; az Ön esetéről beszélünk.

Recidíva: a fogak újra torlódtak

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: Hibáztatás nélkül az okról és a megoldásról**

Klinikai keret (az orvosnak): Korábban fogszabályozó kezelésen átesett páciens; a retenciót abbahagyta, vagy a rögzítő eltört, a fogak elmozdultak. Korlátozott újrakezelés és hosszú távú retenció.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Gyakori jelenség, hogy a fogak az évekkel ezelőtti kezelés után újra elmozdulni kezdenek. A fogak egész életen át végezhetnek kisebb mozgásokat; ha a rögzítőt abbahagyják vagy eltörik, ezek a mozgások kifejezettebbé válhatnak. Ez nem feltétlenül az Ön vagy a korábbi orvosa hibája. A vizsgálaton értékeltük, mekkora a mostani elmozdulás, és hogyan érinti a harapását. A legtöbb recidívánál elég lehet egy rövidebb, korlátozott kezelés, amely nem érinti a teljes fogazatot. Ezúttal azonban beszéljük meg a retenciós tervet már az elejétől, és fogadjuk el, hogy hosszú távú lesz. Ha az elmozdulás a harapását is érinti, a tervet ennek megfelelően bővítjük.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Ezúttal a kezelés után rögzített lingvális retenciós drót és éjszaka viselt átlátszó retenciós sín együttes használatát is javasolhatjuk. A retenció gondozása és ellenőrzése a kezelés része.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A korábbi kezelését rosszul csinálták.	✓ A fogak idővel elmozdulhatnak; koncentráljunk arra, mit tehetünk most.
✗ Ha nem hagyta volna abba a retenciót...	✓ Ezúttal készítsük el együtt a retenciós tervet már az elejétől.
✗ Most biztosan végleges lesz.	✓ Hosszú távú retencióval igyekszünk megőrizni az eredményt.

Csak az elülső fogakat kérő felnőtt

Kinek: Páciens (felnőtt) **Fő üzenet: A korlátozott kezelés határai legyenek írásban**

Klinikai keret (az orvosnak): Felnőtt; csak a mosolyban látható elülső fogak rendezését kéri. A hátsó harapás elfogadható, vagy a páciens nem kér átfogó kezelést. A korlátozott kezelés céljait egyértelműen rögzíteni kell.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Értem, hogy leginkább a mosolygáskor látható elülső fogak zavarják. Az Ön esetében lehetséges lehet egy csak az elülső fogakra összpontosító, korlátozott kezelés. Ennek vannak előnyei: általában rövidebb, és kevesebb készüléket igényel. A korlátozott kezelés határait azonban Önnek is ismernie kell. A hátsó fogak harapásán és az állcsontok közötti viszonyon nem változtatunk, így egyes problémák változatlanok maradnak. Ha pedig az elülső fogak rendezéséhez hely kell, azt a fogak oldalfelszínéről történő kimért zománceltávolítással nyerhetjük. Határozzuk meg együtt, írásban, mit céloz a kezelés és mit nem; így a végén mindketten ugyanazt várjuk.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«Korlátozott kezelésnél az elülső fogakra bracket vagy átlátszó sín kerülhet. Egyes esetekben IPR-rel nyerünk egy kis helyet. A korlátozott kezelés is retenciót igényel.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ Megnézzük az elsőket, a hátsók nem számítanak.	✓ A hátsó harapáson nem változtatunk; elmagyarázom, mit jelent ez.
✗ A korlátozott kezelés mindent megold.	✓ Rögzítsük írásban a céljainkat és a határokat.
✗ Ha nem vállalja a teljes kezelést, megbánja.	✓ Elmondom, mit tenne hozzá az átfogó kezelés; a választás az Öné.

Állkapocsízületi (TMI) panaszos páciens

Kinek: Páciens | Fő üzenet: A fogszabályozás nem TMI-kezelés

Klinikai keret (az orvosnak): A páciens állkapocsfájdalmat, ízületi hangot vagy korlátozott szájnyitást jelez. Fogszabályozás előtt TMI-értékelés, szükség esetén beutalás a megfelelő szakorvoshoz; az elvárások kezelése.

MIT MONDJUNK A PÁCIENSNEK

«Elmondta, hogy fájdalmat, ízületi hangot vagy szájnyitáskor nehézséget érez az állkapocsízületében; ezt komolyan veszem. Szeretném egyértelműen jelezni, hogy a fogszabályozó kezelés önmagában nem módszer az állkapocsízületi problémák kezelésére. Ezért először külön szeretném értékelni az ízületi panaszát, és szükség esetén kikérni egy ezen a területen dolgozó szakorvos véleményét. Ha a panasza kontroll alatt van, megtervezhetjük a fogszabályozó kezelést a fogak elrendeződésére és a harapásra. Ha a kezelés alatt az ízületi panaszában változást észlel, kérem, azonnal szóljon; szüneteltethetjük vagy módosíthatjuk a tervet. A kiindulási állapotot dokumentáljuk, és minden kontrollon összevetjük.»

HA EXTRAKCIÓ VAGY KÉSZÜLÉK KELL, HOGYAN MAGYARÁZZUK

«A kezelés során minden kontrollon rákérdezek az ízületi panaszára, és feljegyzem. Szükség esetén csökkentjük az erőket, vagy szüneteltetjük a kezelést. Ha éjszakai sínre van szükség, azt a megfelelő szakorvossal közösen tervezzük meg.»

KERÜLENDŐ KIFEJEZÉSEK

NE MONDD	HELYETTE
✗ A fogszabályozóval elmúlik az állkapocsfájdalma.	✓ A fogszabályozás nem az ízületi problémák kezelése; az ízületet értékeljük külön.
✗ Rossz a harapása, attól fáj.	✓ A fájdalomnak több oka is lehet; ezt külön kell értékelnünk.
✗ Nem komoly dolog.	✓ A panaszát dokumentálom, és minden kontrollon követem.

8. FEJEZET

Ellenőrzőlista a tájékoztatás után

Mielőtt a páciens vagy a szülő elhagyja a rendelődet, nézd át ezt a listát.

A tájékoztatás után

- [ ] A páciens fő panaszát és elvárását összevetettem a tervvel.
- [ ] A leleteket szakkifejezések nélkül, leíró módon magyaráztam el.
- [ ] Elmondtam a javasolt tervet és annak okát.
- [ ] Elmondtam a többi lehetőséget, a megfigyelést és a kezelés elhagyását is beleértve.
- [ ] Ha extrakció, minicsavar, készülék vagy műtét szükséges, azt külön és nyugodt hangon elmagyaráztam.
- [ ] Az időtartamot hozzávetőleges sávként adtam meg; pontos időt nem mondtam.
- [ ] Egyenként felsoroltam a páciens feladatait (higiénia, elasztikus, készülék, kontroll, retenció).
- [ ] Megkértem a pácienst, hogy foglalja össze a saját szavaival, amit elmondtam.
- [ ] Átadtam az egyoldalas írásos tervet.
- [ ] Jeleztem a rendelőnk által használt beleegyező nyilatkozatot, és azt, hogy időt adok a döntésre.
- [ ] Tisztáztam a következő lépést (dokumentáció, konzultáció, kontroll vagy kezeléskezdési időpont).

JELZÉS A PÁCIENS RÉSZÉRŐL	MIT TEGYÉL
Elhallgatott, nem kérdez	Kérdezz nyitottan: «Melyik rész aggasztja leginkább?»
Rögtön az árat kérdezi	Először foglald össze, mit tartalmaz a terv; a díjakról a rendelőd szokásos módján tájékoztass.

JELZÉS A PÁCIENS RÉSZÉRŐL	MIT TEGYÉL
Azt mondja: «Átgondolom»	Ez egészséges válasz. Add át az írásos tervet, és javasolj időpontot a következő lépésre.
A szülők másképp gondolják	Foglald össze külön mindkét fél aggodalmát; a közös pontból indulj ki (3. bónusz).
Egy másik orvos javaslatát idézi	Kommentár nélkül hasonlítsd össze a két terv céljait (2. bónusz, a vonatkozó kérdés).

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha írásban szeretnéd átadni a tervet a páciensnek, nyisd meg az **1. bónusz · A kezelési terv egy oldalon: magyarázó sablonok** fájlt. A páciens nehéz kérdéseire való felkészüléshez: **2. bónusz · A páciensek 30 leggyakoribb nehéz kérdése és a válaszok**. Magának a tervnek a felépítéséhez a Kézikönyv **3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig** része.